EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88829
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-18 13:20:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BELARMINO ANTONIO DE LA FUENTE ORTEGA			RUN	: 5.629.685-9
F.Nac	: 12-07-2024	Edad	: 0 AÑO	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-07-12	Fecha Egreso	: 2024-07-18 13:20:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R10.0-ABDOMEN AGUDO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Sepsis foco abdominal en vias de resolucion
a) Gastroenterocolitis aguda
2) ERC en HD
3) DM2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. A09-OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO Y NO ES (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta el 10/07 por cuadro de 4 dias de evolucion de CEG, algia abdominal difusa tipo colico, deposiciones diarreicas, con mucosidad, sin sangre, fiebre intermitente. A su ingreso se describe taquicardico,normotenso. Ex fisico se describe abdomen depresible, dolor a la palpacion profunda, difusa.
Ex de lab al ingreso con PCR 240, Gb 31,1; Hb 8,8, hoja hepatica normal. SE decide ingreso en hospital de Parral para manejo.,
Evaluado por sospecha de bacteremia asociado a CVC, se inicia en primera instancia cefazolina previa toma de HC. SE reevalua en conjunto con medicina interna, sin signos sugerentes de infeccion de sitio de insercion de cateter. Se sugiere foco abdominal. Rotavirus, adenoviros y C Difficcile (-). Se cambia terapia ATB a ceftriaxona/metronidazol. Dia 12/07 paciente trasladado a hospital de origen para continuar con manejo (primera atencion otorgada en Hospital de Parral).
TAC AP solicitado compatible con enterocolitis, evaluado por cirugia, sin criterio quirurgico
Paciente HDN estable, afebril, con menor algia abdominal en comparativa a dias previos, con buena tolerancia a VO; sin episodios de nauseas y/o vomitos, diuresis y deposiciones (+)
Examenes de lab -> crea 6,1; PCR 144,8; Na/K/Cl 131/3.5/96; GB 12,2; Hb/Hcto 7.5/23.4; plaq 210000; segment 83%; INR 1,31;
Ex fisico -> Vigil; CLOTE, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extermidades sin edema, sin signos de TVP

Paciente actualmente en su dia N°7 hospitalizado, dia N° 8 de ceftriaxona y dia N° 7 de metronidazol, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: estable, sin conflicto
3) Infeccioso/GI: con parametros inflamatorios a la baja, se continuara con terapia ATB y hospitalizacion via HODOm, se controlara con parmetros inflamatorios en 48 hs

INDICACIONES AL ALTA

1. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 2 dias mas (Total 10 dias)
2. Metronidazol 500 mg c/8hrs VO por 3 dias mas (total 10 dias)
3. Omeprazol 20 gm al dia VO por 3 dias
4. Metoclopramida 10 mg c/12 hrs VO por 3 dias
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/12 hrs VO por 3 dias
6. Dolospam un comp c/8hrs VO por 3 dias
7. Examenes de control dentro de 48 hrs

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO